PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Infecção e retorno ao treino

Sintoma leve, febre e suspeita de miocardite

Medicina Esportiva Clínica

TRÊS MENSAGENS NO MESMO DIA

Uma escada de três decisões

“Garganta arranhando, treino hoje?”

decide-se à beira do treino

“A febre passou ontem, posso correr?”

pede um plano de dias

“Falaram em miocardite, mas estou ótimo.”

sai das mãos da comissão

ANTES DAS DECISÕES

Janela aberta ou gestão de carga

A leitura antiga: a janela aberta

~~esforço intenso suprime a imunidade~~

~~o atleta fica vulnerável por horas~~

~~a solução vira suplemento~~

A leitura atual: gestão de carga

a queda de linfócitos é redistribuição; treino regular melhora a imunidade



> Quem adoece três, quatro vezes por temporada quase nunca tem problema imunológico. Tem problema de planejamento.

Revisão de 2018, Front Immunol · Consenso do COI, Br J Sports Med 2016

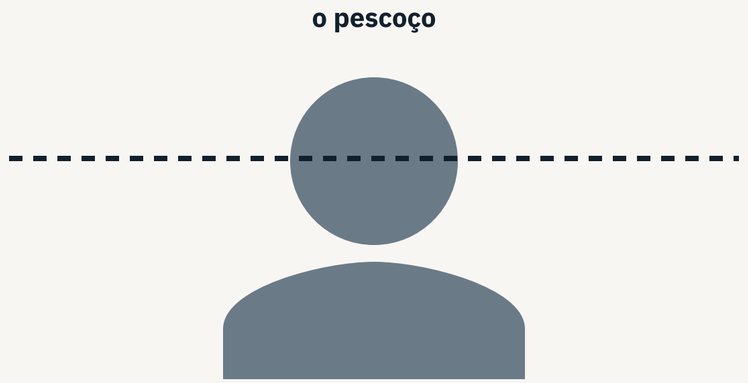
A MENSAGEM DA SEXTA

O teste do pescoço

Acima do pescoço, sem febre

coriza, espirro, nariz entupido; dor de garganta leve

treino leve a moderado; reavalia no dia seguinte



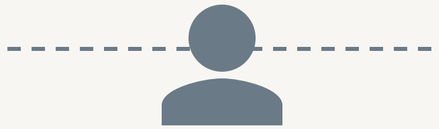
Abaixo do pescoço

febre, calafrio, tosse produtiva; aperto no peito, falta de ar; dor muscular difusa, vômito, diarreia

não treina

Pragmática e útil, sem ensaio de alta qualidade por trás. Leve é leve de verdade, a decisão de sexta não vale para sábado, e um sintoma de baixo basta.

Parar e avaliar, onde quer que esteja o sintoma



o teste do pescoço
não vale quando:

Qualquer febre

é a linha vermelha da aula

Sintoma cardiopulmonar

dor no peito, palpitação, falta de ar desproporcional, tontura no esforço

Doença transmissível na equipe

vestiário, ônibus e alojamento: afastar protege o grupo

Com febre, não se treina

O coração

miocardite está entre as causas de morte súbita em atletas jovens

Água e eletrólitos

febre, suor, vômito: começa o treino em déficit



O calor

febre já desloca o termostato; o exercício soma calor

O rendimento

força e resistência caem; o treino prolonga a doença

> Um dia de treino perdido não muda uma temporada. Uma miocardite muda uma vida.

Não é sim nem não: é assim

Antes de começar

- ✓ 24 h sem febre e sem antitérmico
- ✓ sem dor difusa
- ✓ comendo, bebendo, dormindo

≈ 1 dia de retomada por dia de doença sistêmica

Degrau 1
atividade leve e curta, sem estímulo intenso

Degrau 2
volume habitual, intensidade reduzida

Degrau 3
volta dos estímulos de intensidade

Degrau 4
treino completo e competição

Prática, não evidência forte: cerca de um dia de retomada para cada dia de doença sistêmica.

A LISTA QUE PRECISA ESTAR DECORADA

Sinais que interrompem a volta

Dor ou aperto no peito

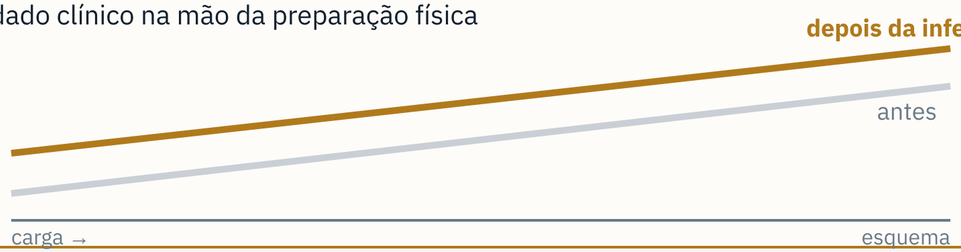
Falta de ar desproporcional

Palpitação

Tontura ou desmaio

FC alta para a mesma carga

dado clínico na mão da preparação física



Fadiga que não cede

mesmo com dias fáceis

Depois de infecção, isso não é destreino. É motivo para parar e investigar o miocárdio.

A TERCEIRA MENSAGEM

Quando o assunto sai da comissão

Miocardite

abstenção; retorno considerado em

3 a 6 meses

com os exames:

- ECG
- Holter
- teste de esforço
- ressonância

Mononucleose

baço aumentado: fora do contato e do esforço vigoroso por semanas

Sintoma cardiopulmonar

dor, falta de ar, palpitação, síncope: não volta sem avaliação

> “Estou ótimo” não é critério. Quem tem miocardite em resolução se sente bem em repouso; o risco aparece no esforço.

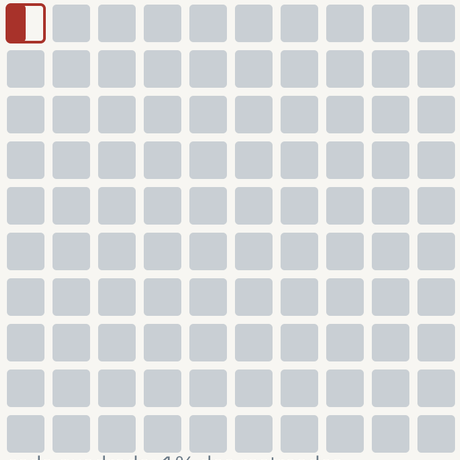
Diretrizes europeias de cardiologia do esporte, Eur Heart J 2021

O DADO QUE ENSINA A LÓGICA

Escalar por sintoma, não rastrear todo mundo

3.018

atletas universitários rastreados depois da infecção



cada quadrado: 1% dos rastreados

< 1%

com acometimento cardíaco provável ou definido

O critério para investigar

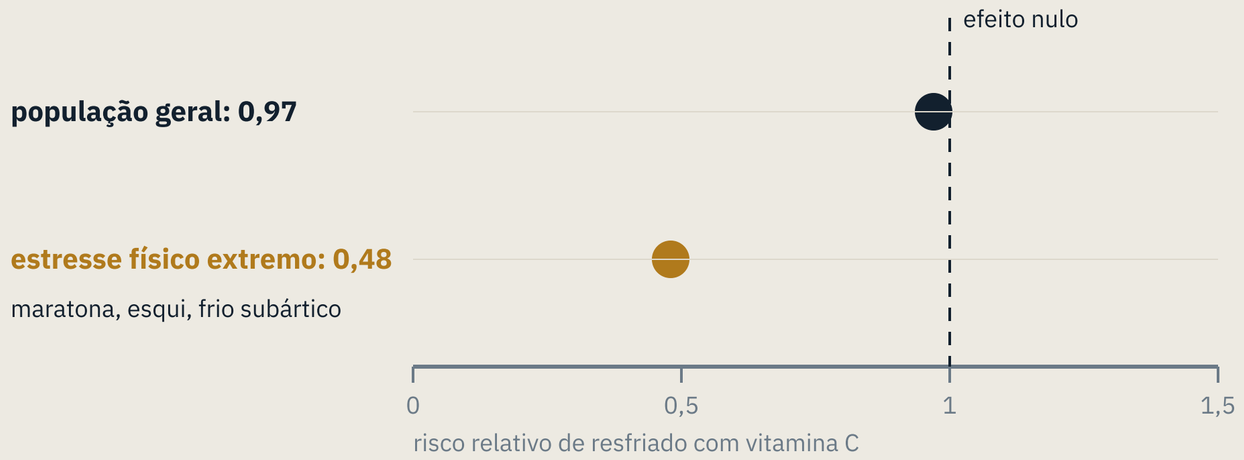
sintoma cardiopulmonar e gravidade da doença

> Rastrear todos com imagem avançada gera mais falso-positivo e afastamento desnecessário que benefício. A minoria real se acha pelo sintoma.

Registro americano ORCCA, Circulation 2021

Gestão, não farmácia

- sono
- energia
- carga
- vacina
- higiene de vestiário
- viagem



> Achado de subgrupo não é passe livre para vender vitamina C. A base não cabe num frasco.

Revisão Cochrane de vitamina C e resfriado, 2013

AS TRÊS MENSAGENS, RESPONDIDAS

Leve com reavaliação, degraus depois da febre, cardiologia na miocardite

- Com febre não se treina; a contagem começa depois dela
- Sintoma cardiopulmonar depois de infecção é investigação, não destreino
- Quem adoece toda temporada tem problema de carga, sono e energia

Médico

Decide o retorno depois de doença sistêmica, investiga e libera.

Preparação física

Aplica o teste do pescoço, reduz a sessão, monitora FC na volta.

A instituição

Sono, energia, vacina, higiene do vestiário, calendário.

A comissão não vota na miocardite. Sustenta a decisão contra o calendário.